

Reisemedizin: Malaria-Update 2025



WHO-Zahlen, neue Bedrohungen und was
deutsche reisemedizinisch tätige
Ärzt:innen jetzt praktisch brauchen

“Therapie-/Prophylaxeentscheidungen erfolgen
patientenindividuell nach aktuellen Leitlinien
(z.B. DTG/RKI) und Fachinformationen [3, 4, 5].

— Redaktion Gelbe Liste



Kernaussagen in 60 Sekunden

282 Mio. Malariafälle 2024

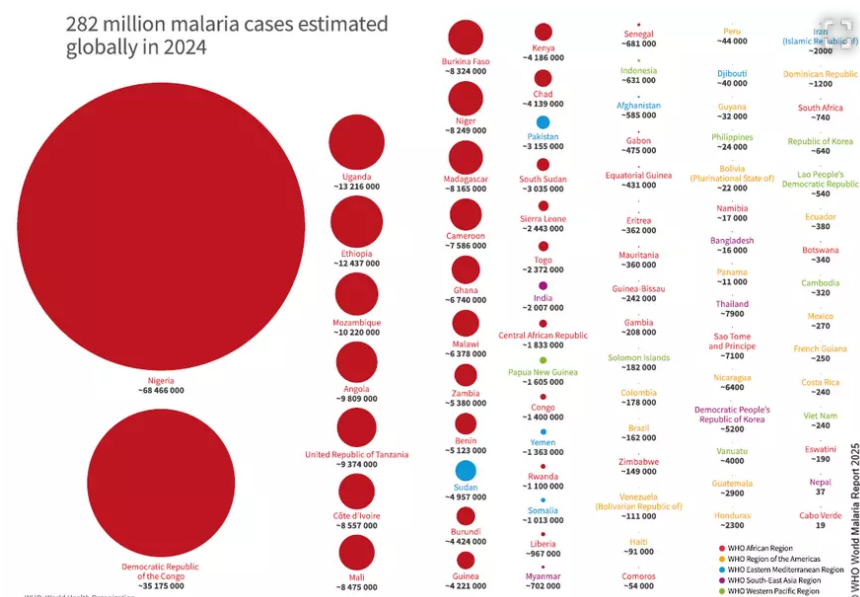
+9 Mio. (+3%) im Vergleich zu 2023 [2]

“ Inzidenz steigt [2]

2024 64,0 Fälle pro 1.000 Risikopersonen
(+2%).

2023 62,7 Fälle pro 1.000 Risikopersonen

“ Fünf Länder bündeln fast die Hälfte der Fälle (49,5%) [2]:



24,3% Nigeria

12,5% DR Kongo



4,7% Uganda
4,4% Äthiopien
3,6% Mosambik

610.000 Todesfälle 2024

+12.000 gegenüber 2023 [2]

“ Neue Bedrohungslage (biologisch)

Artemisinin-Teilverzögerungsresistenz ist in Afrika in **4 Ländern bestätigt** (u.a. Ruanda, Uganda) und in **4 weiteren verdächtig** [2].

“ Diagnostik-Risiko

Parasiten mit **pfhrp2/3-Deletionen** können HRP2-Schnelltests unterlaufen (WHO-Empfehlung: bei >5% falsch-negativen HRP2-RDTs Umstieg auf Pf-LDH-basierte Strategien) [2].

“ Reisemedizin in Deutschland – die Praxis bleibt klar

Expositionsprophylaxe + risikoadaptierte Chemoprophylaxe oder Standby [3, 4, 5]. **Atovaquon/Proguanil** ist in der reisemedizinischen Praxis eine **sehr häufige Standardoption** (v.a. für Kurz- und Last-Minute-Reisen; kurzer Nachlauf) [3, 6, 7].

Die WHO-Zahlen 2024: was sich global verändert



Der *World Malaria Report 2025* zeichnet kein lineares „Erfolg-nach-unten“-Narrativ, sondern eine Gleichzeitigkeit: **Innovation wirkt**, aber **Systembrüche und biologische Anpassungen** holen Fortschritte ein. 2024 registriert die WHO wieder **mehr Fälle** und **mehr Todesfälle** als im Vorjahr – der Zuwachs ist stark auf einzelne Länder und Krisenkontexte konzentriert [2].

Die wichtigsten Trends

- **Fallanstieg konzentriert:** Drei Länder erklären **58%** des Anstiegs 2023→2024: Äthiopien (+2,9 Mio.), Madagaskar (+1,9 Mio.), Jemen (+378.000) [2].
- **Todesanstieg konzentriert:** Drei Länder erklären **85%** des Anstiegs: Madagaskar (+4.900), Äthiopien (+3.800), Jemen (+932) [2].
- **Treiber:** WHO nennt u. a. Konflikt und extreme Klimaereignisse als Faktoren, die Versorgung und Prävention unterbrechen [2].
- **Finanzierung als systemische Engstelle:** 2024 decken globale Mittel nur **42%** des Bedarfs zur Zielerreichung; 2025 verschärfen abrupte Kürzungen externer Hilfen die Lage [2].

Warum das für Deutschland relevant ist

Für Ärzt:innen in Deutschland ist Malaria in der Regel **importierte Malaria** (Reise- und Rückkehrermedizin). Gerade deshalb ist der WHO-Report

relevant – nicht als „Fernproblem“, sondern als **Risikohintergrund** für Beratung, Diagnostik und Triage [2]:

1. **Mehr Transmission global** erhöht das Grundrisiko für Reisende – insbesondere bei Afrika-Reisen [2].
2. **Versorgungsunterbrechungen** in Endemiegebieten erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass Reisende vor Ort suboptimal versorgt werden (z.B. falsche/gefälschte Präparate, unvollständige Therapien) – was Anamnese und Nachsorge komplexer macht [2].
3. **Diagnostik-Fallstricke** (z.B. HRP2-RDT-Limitationen) sind für deutsche Praxen relevant, wenn Patient:innen „negativ getestet“ aus dem Ausland zurückkommen, aber klinisch passen [2].

Praxisblock 1:

Reisemedizinische Beratung – die Risiko-Logik

Wie wird aus Zielgebiet, Reiseprofil, Saison, Höhenlage und „Access-to-care“ eine saubere Entscheidung? Dieser Block gibt eine kompakte **Entscheidungslogik** für die Beratung: Immer Expositionsprophylaxe – und je nach Risiko Chemoprophylaxe und/oder Standby [3, 4, 5].

Schritt 1:

Exposition einschätzen



- Region (Land und Subregion), Saison (Regenzeit), Höhenlage, urban/

remote

- Reiseart (Rucksack/Outdoor/Nachtaktivität vs. Resort/Business)
- Unterkunft (Netz/AC/geschlossene Räume)

Schritt 2:

Patient:innenprofil

- Schwangerschaft, Kinder, Immunsuppression
- Komedikation (z.B. Antikoagulation), Nieren-/Leberfunktion
- Adhärenz realistisch?

Schritt 3:

Zugang zu medizinischer Versorgung („Access-to-care“)

“ Diese Frage entscheidet oft zwischen **Chemoprophylaxe** und **Standby/Notfallselbstbehandlung**:

Ist eine adäquate Diagnostik/Therapie binnen 24–48 Stunden realistisch erreichbar?

Die DTG nutzt genau diese Logik für die Frage, wann eine Notfallselbstbehandlung überhaupt verordnet werden sollte [3].

Praxisblock 2:



Chemoprophylaxe – Atovaquon/Proguanil als Standardoption („Gold-Standard“ in der Praxis, aber individuell)

In der Reisemedizin wird **Atovaquon/Proguanil (A/P)** sehr häufig als **Standardoption** eingesetzt – vor allem, weil es für viele Reisekonstellationen praktisch ist: kurzer Vorlauf, tägliche Einnahme, kurzer Nachlauf und gute Verträglichkeit. Die DTG beschreibt A/P explizit als besonders geeignet für **Last-Minute- und Kurzreisen** in Gebiete mit *P. falciparum*-Risiko [3].

Warum A/P in der Beratung so oft vorn liegt

- **Schneller Start:** Beginn typischerweise **1–2 Tage vor Reise** (Last-Minute-tauglich) [3, 6, 7]
- **Kurzer Nachlauf:** Einnahme **bis 7 Tage nach Verlassen** des Risikogebiets (im Vergleich zu längeren Nachlaufzeiten anderer Optionen) [3, 6, 7]
- **Praktikabilität:** tägliche Routine, häufig gute Verträglichkeit [6, 7]

“ Atovaquon/Proguanil ist in der reisemedizinischen Praxis eine sehr häufige Standardoption der Chemoprophylaxe. Die konkrete Auswahl erfolgt jedoch immer zielgebiets- und patientenindividuell nach aktuellen Empfehlungen (z.B. DTG/RKI) und Fachinformationen [3, 4, 5].

Wichtiger Hinweis

- Nicht empfohlen bzw. eingeschränkt je nach Situation (z.B. schwere Niereninsuffizienz, bestimmte Schwangerschafts-/Stillkonstellationen; Interaktionen z.B. mit Warfarin sind zu beachten) [3, 5, 6, 7]

Je nach Zielgebiet/Resistenzlage und Patient:innenprofil kommen u.a. Doxycyclin oder Mefloquin in Betracht; Doxycyclin ist laut DTG wirksam, aber in Deutschland für diese Indikation formal Off-Label [3].



Praxisblock 3:

Standby-Therapie / Notfallselbstbehandlung – wann sie sinnvoll ist und warum A/P auch hier wichtig ist

Viele deutsche Kolleg:innen nutzen Standby als pragmatische Lösung bei **geringerem Risiko**, wenn zugleich **medizinische Versorgung nicht zuverlässig erreichbar** ist. Die DTG beschreibt hierfür klare Kriterien und betont: Notfallselbstbehandlung ist eine **Ausnahme-Strategie** und ersetzt nicht die ärztliche Abklärung [3].

Wann Standby (NSB) überhaupt in Frage kommt

“ Kurz gesagt: Wenn Malaria-Risiko besteht, aber eine ärztliche Diagnostik/Therapie innerhalb von 48 Stunden nicht sicher erreichbar ist – insbesondere bei längeren Aufenthalten oder „unklarer Versorgungslage“ [3, 5].

Was als Standby verwendet wird (und warum A/P hier zentral ist)

Die DTG nennt als NSB-Optionen u.a. **Atovaquon/Proguanil** oder **Artemether/Lumefantrin**; wichtig ist zudem der **Hinweis**, dass **Artemether/Lumefantrin** für Reisen nach **Teilen Südostasiens nicht empfohlen** wird – dort wird A/P als NSB hervorgehoben [3].

“ **Standby/Notfallselbstbehandlung nur nach ärztlicher Einweisung:**

Bei Fieber ($\geq 38^\circ\text{C}$) möglichst sofort ärztliche Hilfe suchen. Standby nur einsetzen, wenn eine qualifizierte Abklärung innerhalb von 48 Stunden nicht erreichbar ist – und dennoch so rasch wie möglich ärztlich kontrollieren lassen [5].

Praxisblock 4:

Rückkehrerfieber – Diagnostik, typische Fallstricke, „rote Flaggen“

Hier entscheidet sich **Relevanz für Deutschland:** Die meisten Ärzt:innen sehen **Malaria nicht täglich**, aber sie müssen sie **schnell erkennen** [4].

“ **Fieber nach Aufenthalt in einem Malariagebiet ist ein medizinischer Notfall, bis Malaria ausgeschlossen ist.**

Das gilt besonders bei Rückkehr aus Afrika und auch dann, wenn im Ausland „ein Schnelltest negativ“ war [2, 4].

Warum „negativer Schnelltest“ nicht reicht

Die WHO beschreibt **pfhrp2/3-Deletionen** als biologische Bedrohung, weil HRP2-basierte Schnelltests dadurch falsch negativ werden können. Bei relevanter Rate falsch-negativer HRP2-RDTs empfiehlt WHO eine Pf-LDH-basierte Strategie [2].

Praktische Übersetzung:

- “ Wenn Anamnese und Klinik passen, nicht beruhigen lassen! Weiter abklären, ggf. wiederholen und tropenmedizinische Expertise einholen [4].

Resistenzen & Diagnostik-Evasion: Was Ärzt:innen wissen sollten (ohne Alarmismus)

Artemisinin-Teilverzögerungsresistenz: neue Realität in Afrika

Der WHO-Report dokumentiert: **Vier Länder** haben bestätigte Artemisinin-Teilverzögerungsresistenz (Eritrea, Ruanda, Uganda, Tansania), **vier weitere** zeigen verdächtige Signale (Äthiopien, Namibia, Sudan, Sambia). Klinisch ist bislang vor allem **verzögerte Parasiten-Clearance** beschrieben; ACTs bleiben vielerorts wirksam, solange Partnerdrugs tragen – genau deshalb ist Surveillance entscheidend [2].

Frühe Signale bei Partnerdrug-Wirksamkeit: wachsam bleiben

WHO berichtet, dass in einzelnen Studienstandorten Behandlungsausfälle >10% (z.B. für Artemether/Lumefantrine) beobachtet wurden, ohne dass

Lumefantrin-Resistenz eindeutig bestätigt ist [2].

“ Die Botschaft ist nicht „Panik“, sondern: **Therapieausfälle ernst nehmen, Methodik beachten, Qualität der TES stärken** [2].

> Weitere aktuelle reisemedizinische Informationen auf Gelbe-Liste.de >

Literatur & Quellenangaben:

1. World Health Organization. World malaria report 2025: addressing the threat of antimalarial drug resistance. Geneva: World Health Organization; 2025. Available from: <https://iris.who.int/items/45093170-6d1f-4a8b-b34e-beef35776cbd> (accessed 2025 Dec 17)
2. World Health Organization. World malaria report 2025: addressing the threat of antimalarial drug resistance [Internet]. 2025 Dec 4 [cited 2025 Dec 17]. Available from: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240117822>
3. Rothe C, Veit O, Rosenbusch D, Bühler S, Feldt T, Frühwein M, et al. Empfehlungen zur Malariaprophylaxe. Flugmed Tropenmed Reisemed. 2024; 31(4):165–206. doi:10.1055/a-2351-8414
4. Deutsche Gesellschaft für Tropenmedizin, Reisemedizin und Globale Gesundheit (DTG). DTG-Empfehlungen Malaria [PDF/Internet]. 2024 [cited 2025 Dec 17]. Available from: https://www.dtg.org/images/Startseite-Download-Box/2024_DTG_Empfehlungen_Malaria.pdf
5. Robert Koch-Institut. RKI-Ratgeber: Malaria [Internet]. [cited 2025 Dec 17]. Available from: https://www.rki.de/DE/Aktuelles/Publikationen/RKI-Ratgeber/Ratgeber/Ratgeber_Malaria.html
6. Auswärtiges Amt (Gesundheitsdienst). Malaria: Empfehlungen zur Vorbeugung und Notfallselftbehandlung im Auswärtigen Amt und im Deutschen Archäologischen Institut (Stand: 05/22/GB) [PDF/Internet]. 2022 [cited 2025 Dec 17]. Available from: <https://www.auswaertiges-amt.de/resource/blob/200176/2118770c95ac9a07dab343e6cb3ebd9/malariamerkblatt-data.pdf>
7. Centers for Disease Control and Prevention. Malaria. In: CDC Yellow Book (Health information for international travel) [Internet]. 2025 Apr 23 [cited 2025 Dec 17]. Available from: <https://www.cdc.gov/yellow-book/hcp/travel-associated-infections-diseases/malaria.html>
8. Centers for Disease Control and Prevention. Choosing a drug to prevent malaria [Internet]. 2024 Jul 18 [cited 2025 Dec 17]. Available from: <https://www.cdc.gov/malaria/hcp/drug-malaria/index.html>

> Weitere aktuelle reisemedizinische Informationen auf Gelbe-Liste.de >

